

CHIRURGIE
DIGESTIVE
ET
UROLOGIQUE

EXERCICE 1

I-QUESTIONS A CHOIX DOUBLE (QCD)

Choisir : A=VRAI ; B=FAUX

1. La hernie crurale ou fémorale survient le plus souvent chez les hommes de 30 à 60 ans, obèses
2. La hernie épigastrique fait partie des hernies de la ligne blanche
3. L'arrêt des matières et des gaz est un signe fonctionnel de l'étranglement herniaire
4. Le choc indirect dans les contusions abdominale est secondaire à une percussion et déterminant des lésions d'éclatement, de dilacération ou d'écrasement
5. Le contus de l'abdomen présent des douleurs abdominales d'apparition progressive
6. Les signes d'épanchement liquidien intrapéritonéal sont présent dans le tableau de péritonite par perforation chez le patient contus de l'abdomen
7. La ponction lavage du péritoine permet de faire le diagnostic d'un hémopéritoine avec la perforation d'un viscère creux
8. La pollakiurie nocturne et/ou diurne est le premier symptôme observé chez le patient atteint d'adénome de la prostate
9. Si le résidu post-mictionnel est ≥ 300 CC, on parle de rétention sans distension
10. Tout malade présentant une occlusion doit être hospitaliser en milieu chirurgical
11. Lorsque le test est négatif dans la ponction lavage du péritoine, le liquide est plus ou moins rosé, fait une NFS dans ce cas
12. En cas de contusion pariétale simple, 48 à 72 h suffisent pour libérer le malade
13. On poursuit la réanimation en post opératoire chez le patient victime d'une contusion abdominale
14. En cas de contusion abdominale, le traumatisme peut entrainer des lésions des viscères intraabdominaux
15. Les contusions sont des traumatismes fermés dans l'abdomen
16. La hernie peut être congénitale ou acquise
17. Les hernies inguinale et crurale constituent les hernies de l'aîne
18. L'abdomen est la partie médiane du tronc

II-QUESTIONS A CHOIX MULTIPLE (QCM)

Choisir la ou les réponse(s) juste(s)

19. Ces facteurs ci-dessous cités sont des facteurs favorisant les hernies.
- A- Travail de force
 - B- Appendicite aigue
 - C- Constipation chronique
 - D- Cholécystite aigue
 - E- Iléite terminale
 - F- Toux chronique
20. Le rétablissement de la volémie se fait avec deux des propositions ci-dessous lesquelles
- A- Injection d antianémique
 - B- Par perfusion de macromolécule
 - C- Par rapport sanguin
 - D- Injection d hémostatique
21. Les objectifs des soins infirmiers pour le client qui doit subir une appendicectomie sont les suivants :
- A- Apporter un soulagement physique pendant la période periopératoire
 - B- Administrer le traitement prescrit
 - C- Réduire l'anxiété ou le stress précédant l'opération en fournissant des informations au client sur la période periopératoire
22. Parmi les signes ci-dessous cités les signes généraux de l'appendicite aigue
- A- Vomissements alimentaires
 - B- Température : 38-38°5
 - C- Langue saburrale
 - D- Constipation
 - E- Nausées
23. La laparotomie qui est la mieux indiquée en cas de péritonite permet
- A- De laver la cavité péritoine
 - B- De calmer la maladie
 - C- D identifier et traiter la maladie en cause
 - D- De soulager la douleur du malade
 - E- De mettre le malade a l abris du danger
24. Dans l'appendicectomie avec drainage, il faut

- A- Maintenir une succion nasogastrique constante
- B- Enlever les points de suture entre le 5ème et le 7ème jour après l'opération
- C- Donner à manger au malade le même jour de l'opération si son état le permet
- D- Traiter la déshydratation
- E- Le malade peut quitter l'hôpital 48 h plus tard, si la température est normale et s'il ne ressent pas de douleur trop forte dans la région opérée

25. Parmi ces examens donner ceux demandés en cas d'occlusion intestinale aiguë

- A- Lavement baryté
- B- Echographie abdominale
- C- Abdomen sans préparation
- D- Endoscopie digestive
- E- Electrocardiogramme

26. Citer les étiologies des péritonites

- A- Les Ulcères gastro-duodénaux
- B- Abscès du foie
- C- Cholécystite aiguë
- D- Cystite
- E- Colique néphrétique droite
- F- Appendicite rompue

27. Enumérer les positions variables de l'appendicite

- A- Retro sternale
- B- Latero-coecale
- C- Sous-hépatique
- D- Entero-coecale
- E- Retro-caecale

28. Les formes aiguës de l'appendicite aiguë sont

- A- Cholécystite aiguë
- B- Abscès appendiculaire
- C- Stercolithe
- D- Pyélonéphrite droite
- E- Péritonite appendiculaire

29. La surveillance et les soins per et post opératoire dans les interventions infirmières en cas de péritonite consiste à :

- A- Contrôler les constantes biologiques

- B- Préparer le dispositif pour raccorder les drains ou sondes
 - C- Signaler la présence d'infection cutanée
 - D- Contrôler le réveil physiologique du malade
 - E- Prévenir l'hypovolémie à cause des pertes de liquide due aux vomissements
30. Les signes d'anémie aiguë dans le tableau d'hémopéritoine associent :
- A- Une tachycardie superficielle avec parfois battement des ailes du nez
 - B- Une agitation
 - C- Une soif intense
 - D- Une pâleur extrême des téguments et des muqueuses
 - E- Un état syncopal

EXERCICE 2

I-QUESTIONS A CHOIX DOUBLE (QCD)

CHOISIR A=VRAI B=FAUX

1. Le pédicule de la hernie inguinale sort de l'abdomen au-dessous de la ligne de Malgaigne
2. La ligne de Malgaigne est cliniquement repérée par l'épine iliaque antéro inférieure et l'épine du pubis
3. Dans les contusions abdominales les lésions sont provoquées par le choc direct ou décélération
4. L'appendicite retro-caecale se manifeste par une occlusion fébrile
5. L'appendicite méso-cœliaque se manifeste par les psoitits
6. Un pneumopéritoine est cliniquement mis en évidence par la matité déclive des flancs à la percussion
7. Les contusions abdominales sont dues à un choc direct ou à une décélération brutale
8. Le ganglion de Troisier se recherche, au niveau du confluent veineux jugulo-sous clavier gauche
9. Le lavement à l'hydrosoluble peut préciser le siège et l'étiologie d'une occlusion de la grêle

10. Toute occlusion intestinale mécanique entraîne une hypovolémie par création d'un troisième secteur, avec hémococoncentration et spoliation ionique
11. Le cancer du côlon droit se développe dans le territoire vasculaire de l'artère mésentérique inférieure
12. Le toucher rectal explore le péritoine du cul-de-sac de Douglas

II-QUESTIONS A CHOIX MULTIPLE (QCM)

CHOISIR LA/LES REPONSE(S) JUSTE(S)

13. Les signes énumérés ci-dessous sont compatibles avec une crise appendiculaire aiguë
 - A- Douleur de la fosse iliaque droite
 - B- Ténésme
 - C- Fièvre à 38°C
 - D- Hyperleucocytose avec polynucléose
 - E- Défense à la palpation de la fosse iliaque droite
14. L'appendicite aiguë constitue une menace pour la grossesse pour des symptômes évoqués ci-dessous :
 - A- Les vomissements
 - B- Les contractions utérines
 - C- La fièvre
 - D- La constipation
15. Parmi les signes cités ci-dessous quels sont ceux qui constituent le syndrome d'irritation péritonéale ?
 - A- La douleur abdominale
 - B- La douleur au toucher rectal
 - C- La douleur provoquée et la contracture abdominale à la palpation
 - D- La constipation
 - E- Les épreintes
16. Le tableau d'hémorragie interne se manifeste par des symptômes suivants :
 - A- Signes d'anémie aiguë
 - B- Signes de choc hypovolémique
 - C- La diarrhée
 - D- Signes d'irritation péritonéale
 - E- Signes d'épanchement intrapéritonéal
17. Le tableau de péritonite par perforation comprend les signes suivants :

- A- Douleur abdominale d'apparition progressive
 - B- Nausées et vomissements
 - C- Contracture abdominale extensive
 - D- Diarrhée profuse
 - E- Silence abdominale
18. Une hernie inguinale étranglée présente les signes suivants :
- A- Une tuméfaction inguinale
 - B- Irréductible à la palpation
 - C- Impulsive à l'effort
 - D- Expansive à la toux
 - E- Douloureuse à son collet
19. Concernant les occlusions intestinales hautes, relever les assertions correctes :
- A- Elles sont situées au niveau du grêle
 - B- Les images hydro-aériques sont périphériques et plus hautes que larges
 - C- Les vomissements précoces et répétés
 - D- L'altération rapide de l'état général
 - E- La présence d'une cicatrice abdominale est possible
20. Parmi les assertions suivantes lesquelles font évoquées un cancer colique ?
- A- Age supérieur à 60 ans
 - B- Antécédant de polyposes recto colique
 - C- Alternance de diarrhée et constipation
 - D- Hypersialorrhée
 - E- Amaigrissement
21. Concernant l'appendicite aigue, donner les assertions correctes :
- A- C'est l'urgence chirurgicale abdominale la plus fréquente
 - B- Son diagnostic est essentiellement clinique
 - C- Son évolution imprévisible peut se faire vers des complications graves
 - D- Son traitement est essentiellement médical
 - E- Il n'y a pas de parallélisme anatomoclinique
22. Les signes fonctionnels d'une occlusion intestinale
- A- La douleur abdominale
 - B- Ténésme
 - C- Les vomissements
 - D- L'arrêt des matières et gaz

23. Vous devez passer 6 litres de perfusion en 24 heures à un patient. Selon la formule empirique que vous connaissez, trouvez le nombre de gouttes que vous ferez passer par minute parmi les propositions suivantes :
- A- 75 gouttes/min
 - B- 84 gouttes/min
 - C- 90 gouttes/min
 - D- 100 gouttes/min
24. Le diagnostic d'une hydrocèle de la vaginale est évoqué devant :
- A- Tuméfaction non impulsive à l'effort
 - B- Non expansive à la toux
 - C- Réductible
 - D- Translucide à l'épreuve de la torche

EXERCICE 3

1-QUESTIONS A CHOIX DOUBLE

CHOISIR A=VRAI B=FAUX

1. Chez le patient à opérer pour une péritonite appendiculaire, la présence d'un paralytique nécessite la pose d'une sonde nasogastrique
2. En cas de colique nephretique le malade est agité (frénétique)
3. En cas d'appendicite aigue, la température du patient passe de 37°C à 42°C
4. En cas de péritonite, le malade est prostré
5. L'appendicite mesocolique donne un tableau rectite
6. L'arrêt des gaz et des matières sont tardifs dans l'occlusion de la grêle
7. L'ASP est un examen non indispensable dans l'occlusion intestinale
8. La cryptorchidie peut se compliquer par un cancer du testicule
9. La complication redoutable de l'appendicite aigue est la cancérisation
10. La hernie étranglée est irréductible et douloureuse
11. La néphrectomie est un examen radiologie du rein
12. La péritonite est une urgence chirurgicale
13. Le diagnostic de l'appendicite aigue est essentiellement paraclinique

14. Le météorisme est absent dans l'occlusion intestinale haute
15. Le plastron est une contre-indication opératoire
16. Les chutes entraînent des chocs indirects dus à la décélération brutale
17. Les contusions de l'abdomen sont des traumatismes sans solution de continuité au niveau de la paroi abdominale
18. Les contusions sont des traumatismes fermés de l'abdomen
19. Les occlusions intestinales par strangulation posent un problème vasculaire qui aggrave le pronostic
20. Les vomissements sont précoces et abondants dans l'occlusion de la grêle
21. Les occlusions intestinales hautes siègent exclusivement sur le duodénum
22. L'hydrocèle de la vaginale résulte d'une torsion du cordon spermatique
23. Dans les occlusions intestinales, les pertes hydro électrolytiques peuvent entraîner un choc hypovolémique
24. Les occlusions intestinales entraînent des hématemèses qui nécessitent une réanimation immédiate
25. L'appendicite peut être le fait d'une infection de l'appendice par voie hématogène ou par obstruction de la lumière intestinale
26. La cryptorchidie ou l'ectopie testiculaire doit être opérée avant 7 ans pour éviter les complications dégénératives
27. Les contusions abdominales peuvent se compliquer par une occlusion
28. La présence de liquide dans la cavité péritonéale est évoquée par la matité déclive des flancs à la percussion
29. La présence d'un pneumopéritoine est évoquée devant une sonorité pré hépatique, recherchée en décubitus dorsal
30. L'invagination intestinale aigüe réalise une occlusion par strangulation

II. QUESTIONS A CHOIX MULTIPLES

CHOISIR LA /LES REPONSE(S) JUSTE(S)

31. La crise appendiculaire a pour diagnostic différentiel des pathologies ci-dessous :
 - A- Annexite droite
 - B- Hernie inguinale étranglée
 - C- Inflammation du diverticule de Meckel
 - D- Hydrocèle vaginale
32. Parmi les étiologies des occlusions intestinales laquelle est fonctionnelle :

- A- Invagination intestinale
 - B- La tumeur intestinale
 - C- La colique nephretique
33. Le diagnostic présomptif d'une tuméfaction indolente, du scrotum de taille moyenne avec une épreuve de la lampe torche positive, est :
- A- La hernie inguino--scrotale
 - B- La tumeur scrotum
 - C- L hydrocèle vaginale
34. Le gargouillement perçu a la réduction d'une hernie fait suspecter un encastrement :
- A- L épiploon
 - B- De l'intestin
 - C- De fécalome
35. Les signes fonctionnels des occlusions intestinales sont :
- A- La douleur abdominale
 - B- Les vomissements
 - C- Les pétéchiies
 - D- L'arrêt des matières et des gaz
36. Dans les occlusions intestinales, le 3eme secteur de Randall constitué de liquide inutilisable, comprend :
- A- La pollakiurie
 - B- Œdème pariétal
 - C- Le liquide de stase intestinal
 - D- Le liquide de transsudation
37. Le rétablissement de la volémie se fait avec :
- A- Par perfusion de sérum glucosé
 - B- Par injection d hémostatique
 - C- Par perfusion de macromolécule
 - D- Par rapport sanguin
38. Les signes fonctionnels des occlusions intestinales sont :
- A- La douleur abdominale
 - B- Les vomissements
 - C- Les épigastralgie
 - D- L'arrêt des matières et des gaz
39. Les assertions concernant la hernie inguinale directe non compliquée sont :

- A- Elle entraîne une gêne de la région inguinale
- B- Elle est impulsive à l'effort
- C- Expansive à la toux
- D- Elle est réductible selon un trajet oblique en dehors
- E- Son pédicule émerge de la paroi au-dessous de la ligne de Malgaigne

40. Les péritonites se manifestent par les signes suivants :

- A- Les douleurs abdominales
- B- Les vomissements
- C- Une polyarthralgie
- D- L'arrêt du transit
- E- Un vent de bois à la palpation